ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
พ.ศ. ๒๕๖๙

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงให้มีความสอดคล้องกับบริบทการกระจายอำนาจด้านสุขภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) และ (๙) และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติการประชุมของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“องค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล เมืองพัทยาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด และให้หมายความรวมถึงกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด

“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด

“การจัดบริการสาธารณสุข” หมายความว่า การบริการสาธารณสุขในชุมชน เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตนอกเหนือจากการจัดบริการปกติของหน่วยบริการ

“การสร้างเสริมสุขภาพ” หมายความว่า บริการที่มุ่งกระทำเพื่อให้บุคคลมีสุขภาพทางกายและจิตใจที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

“การป้องกันโรค” หมายความว่า บริการที่มุ่งกระทำเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเป็นโรค และการป้องกันไม่ให้กลับเป็นซ้ำในกรณีที่หายจากการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคแล้ว รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการป้องกันโรค

“การฟื้นฟูสมรรถภาพ” หมายความว่า บริการที่มุ่งกระทำเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพหรือความสามารถทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้น โดยอาศัยกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การจัดหาและสนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมของบุคคล เพื่อให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ

“การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก” หมายความว่า การจัดบริการหรือการจัดกิจกรรมสาธารณสุข ซึ่งเป็นการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเบื้องต้นในชุมชน และนอกเหนือจากการจัดบริการปกติของหน่วยบริการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการมากขึ้น

“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

“หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ

“หน่วยงานอื่น” หมายความว่า หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุข

“องค์กรหรือกลุ่มประชาชน” หมายความว่า องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ภาคเอกชน หรือบุคคลที่มีการรวมตัวกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกำไร ทั้งนี้ จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ข้อ ๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) มีความประสงค์เข้าร่วมดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

(๒) มีงบประมาณในการสบทบเงินกองทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน

ข้อ ๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้มีกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข รวมถึงการแก้ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากปัจจัยทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากพฤติกรรมส่วนบุคคล (Determinants of Health) เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้และมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ข้อ ๗ เงินหรือทรัพย์สินในกองทุน ประกอบด้วย

(๑) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือค่าบริการสาธารณสุขอื่นตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกี่ยวกับการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่กำหนดในแต่ละปีงบประมาณ เช่น ค่าบริการแว่นตาสำหรับเด็ก ค่าบริการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย แผ่นเสริมซึมซับ และผ้าอ้อมทางเลือกในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น

(๒) เงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในจำนวนไม่น้อยกว่าที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีที่ได้รับเงินจัดสรรค่าบริการสาธารณสุขอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ทั้งนี้ การสมทบเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำเนินการโดยเร็วเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ กรณีมีความจำเป็นให้สมทบได้ไม่เกินปีงบประมาณที่สำนักงานจ่ายเงินสนับสนุน

(๓) เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์หรือภารกิจที่สอดคล้องกับกองทุนโดยความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงาน

(๔) รายได้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุน

ข้อ ๘ ให้เงินกองทุนตามข้อ ๗ เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และบริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อ ๙ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ ๗ (๑) แล้ว มีเงินคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์กองทุน และมีความประสงค์ขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาจได้รับการจัดสรรเงินเพิ่มเติม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องสมทบเงินตามข้อ ๗ (๒)

ข้อ ๑๐ เพื่อให้การจ่ายเงินกองทุนตามประกาศนี้ไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้พิจารณาดำเนินงานในเขตจังหวัดดังนี้

(๑) ดำเนินงานในโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ

(๒) ดำเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และไม่เข้าไปดำเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดำเนินการได้เอง หรือ

(๓) ดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมากกว่าหนึ่งแห่งขึ้นไป หรือ

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานแทน

ข้อ ๑๑ เงินกองทุนตามข้อ ๗ (๑) (๒) และ (๔) ให้ใช้จ่ายตามที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติดังต่อไปนี้

(๑) สนับสนุนและส่งเสริมแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม รวมทั้งแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชนในจังหวัด เพื่อส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่เข้าถึงการบริการสาธารณสุขและการแก้ปัญหาสุขภาพด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นได้มากขึ้น

(๒) สนับสนุนและส่งเสริมโครงการด้านพัฒนาศักยภาพ การมีส่วนร่วม หรือวิชาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชนในจังหวัด เพื่อให้การบริการสาธารณสุขและการแก้ปัญหาสุขภาพด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นในพื้นที่ให้มีศักยภาพและเข้มแข็งมากขึ้น

(๓) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชนในจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับโรคติดต่อ หรือภัยธรรมชาติ หรือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและสังคมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่

(๔) สนับสนุนและส่งเสริมแผนงาน หรือโครงการ ในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหรือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีประสิทธิภาพให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินกองทุนตามข้อ ๗ (๑) และ ๗ (๒) ในแต่ละปีงบประมาณนั้น และกรณีมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือจัดจ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจำเป็น และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น

(๕) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขอื่นตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย

เงินกองทุนที่ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง หากต้องจัดหาครุภัณฑ์เพื่อจัดบริการสาธารณสุขให้กับบุคคล คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณาสนับสนุนได้ในวงเงินตามความจำเป็น เว้นแต่กรณีองค์กรหรือกลุ่มประชาชนอาจสนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกินสองหมื่นบาทต่อโครงการตามความจำเป็นและเหมาะสม และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ที่ได้รับการสนับสนุน

การพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการกองทุนสามารถเชิญผู้แทนหน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐบาลหรือภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนได้

ข้อ ๑๒ เงินกองทุนตามข้อ ๗ (๓) ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนอื่นที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงาน และหน่วยงานเจ้าของแหล่งทุนนั้น โดยการอนุมัติของคณะกรรมการกองทุน

ข้อ ๑๓ กรณีกองทุนได้รับค่าบริการสาธารณสุขอื่นเพิ่มเติมจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมแผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือแผนการดูแลรายบุคคลตามที่สำนักงานกำหนด โดยการอนุมัติของคณะกรรมการกองทุน

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน สถานการณ์การเกิดโรคระบาด สถานการณ์ภัยพิบัติ หรือสถานการณ์ความไม่สงบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องให้การสนับสนุนหรือจัดบริการด้านสาธารณสุขอย่างเร่งด่วน และการเสนอให้คณะกรรมการกองทุนอนุมัติค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๑ อาจไม่ทันต่อสถานการณ์หรืออยู่ในภาวะที่ไม่อาจเสนอคณะกรรมการกองทุนได้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้เป็นประธานกรรมการตามข้อ ๑๖ มีอำนาจอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขกรณีดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้ถือว่าโครงการหรือกิจกรรมที่ประธานกรรมการอนุมัตินั้นเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติตามประกาศนี้ และให้ประธานกรรมการรายงานให้คณะกรรมการกองทุนทราบโดยเร็ว

ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามวรรคหนึ่ง เป็นบุคคลภายนอกเขตจังหวัดที่มีการอนุมัติโครงการหรือกิจกรรม ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับบริการภายใต้โครงการหรือกิจกรรมตามวรรคหนึ่งเช่นเดียวกับบุคคลภายในเขตจังหวัด

ข้อ ๑๕ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชี การรายงานของกองทุน และการกำกับติดตามเงินกองทุน ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และให้เงินในกองทุนสามารถใช้ในปีงบประมาณถัด ๆ ไปได้

ข้อ ๑๖ ให้มีคณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด	เป็นที่ปรึกษา
(๒) ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	เป็นที่ปรึกษา
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	เป็นประธานกรรมการ
(๔) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	เป็นกรรมการ
(๕) ท้องถิ่นจังหวัด	เป็นกรรมการ
(๖) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	เป็นกรรมการ
(๗) ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดที่กรรมการกองทุนคัดเลือก จำนวนสองคน	เป็นกรรมการ
(๘) ผู้แทนสถาบันการศึกษาในจังหวัด ที่กรรมการกองทุนคัดเลือก จำนวนหนึ่งคน	เป็นกรรมการ
(๙) ผู้แทนองค์กรหรือกลุ่มประชาชนในจังหวัด ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต คัดเลือกโดยกระบวนการมีส่วนร่วม จำนวนสามคน	เป็นกรรมการ
(๑๐) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย จำนวนหนึ่งคน	เป็นกรรมการ
(๑๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย จำนวนหนึ่งคน	เป็นกรรมการ

(๑๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย จำนวนสองคน — เป็นกรรมการ

(๑๓) นักกายภาพบำบัดในหน่วยบริการ ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย จำนวนหนึ่งคน — เป็นกรรมการ

(๑๔) นายกเทศมนตรีที่เป็นผู้แทนระดับจังหวัดของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวนหนึ่งคน — เป็นกรรมการ

(๑๕) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นผู้แทนระดับจังหวัดของสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จำนวนหนึ่งคน — เป็นกรรมการ

(๑๖) ผู้แทนศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองในจังหวัด จำนวนหนึ่งคน — เป็นกรรมการ

(๑๗) ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับจังหวัด — เป็นกรรมการ

(๑๘) เจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ที่ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตมอบหมาย — เป็นกรรมการ

(๑๙) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด — เป็นกรรมการและเลขานุการ

(๒๐) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลังที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบหมาย — เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

(๒๑) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขหรือหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบงานกองทุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบหมาย — เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

(๒๒) เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มอบหมาย — เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๑๗ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๑๖ (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) และ (๑๙)

เมื่อได้กรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการดังกล่าวและกรรมการตามข้อ ๑๖ (๓) (๔) (๕) และ (๖) เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการตามข้อ ๑๖ (๗) และผู้แทนสถาบันการศึกษาให้เป็นกรรมการตามข้อ ๑๖ (๘)

เมื่อได้กรรมการครบองค์ประกอบแล้ว ให้ออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนและแจ้งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ทราบ

ข้อ ๑๘ ให้กรรมการตามข้อ ๑๖ (๗) ถึง (๑๘) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ออกคำสั่งแต่งตั้ง

เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่งแล้ว หากยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการคัดเลือกขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งกรรมการนั้นว่างลง และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดำเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ และในการนี้ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งยังมิได้มีการคัดเลือกกรรมการขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่

ข้อ ๑๙ กรรมการตามข้อ ๑๖ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ย้ายไปดำรงตำแหน่งหรือไปประกอบอาชีพในจังหวัดอื่น

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๗) พ้นจากการดำรงตำแหน่งหรือการเป็นผู้แทนอันเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนตามข้อ ๑๖

(๘) ขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ข้อ ๒๐ การประชุมคณะกรรมการกองทุน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการกองทุนประจำปีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนแล้วเสนอต่อสำนักงานเพื่อทราบ

(๒) พิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม รวมทั้งแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม รวมทั้งแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้เทียบเคียงตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

(๓) ออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

(๔) สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นหรือพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

(๕) ให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลและการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน

(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุน

ข้อ ๒๒ คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้ หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย และให้นำข้อ ๒๐ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน โดยอนุโลม

ข้อ ๒๓ ให้กรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยเลขานุการ อนุกรรมการ คณะทำงาน บุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาประชุม และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ที่ได้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการประชุม หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการประชุมแล้วแต่กรณี

ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๒๔ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดมีเงินกองทุนคงเหลือมากกว่าหนึ่งเท่าของรายรับของกองทุนตามข้อ ๗ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา สำนักงานอาจงดการจัดสรรเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ ๗ (๑) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจงดการสมทบเงินตามข้อ ๗ (๒) ของปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินกองทุนในการบริหารหรือพัฒนากองทุนตามข้อ ๑๑ (๔) ในปีงบประมาณนั้น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินวงเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมา

ข้อ ๒๕ เพื่อให้กองทุนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จัดให้มีกลไกสำหรับส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และดำเนินการกำกับ ติดตามประเมินผล โดยรายงานให้สำนักงานทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ

กรณีพบความไม่ถูกต้องในการใช้จ่ายเงินกองทุน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) ใช้สิทธิตามกฎหมายในการเรียกคืนค่าใช้จ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชนได้รับ

(๒) ระงับ หรือชะลอการจ่ายค่าใช้จ่ายที่พึงได้รับในงวดถัดไป

(๓) ดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการตามวรรคสองแล้ว ให้รายงานให้สำนักงานทราบโดยเร็ว

ข้อ ๒๖ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดไม่สมทบเงิน หรือไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดต่อเนื่องตั้งแต่สองปีงบประมาณขึ้นไป สำนักงานอาจเรียกเงินคืนหรือประกาศยุบเลิกกองทุนได้ และให้การโอนเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด

ข้อ ๒๗ ให้เงินกองทุน คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และการดำเนินงานต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นเงินในกองทุน เป็นคณะกรรมการกองทุน เป็นคณะอนุกรรมการ เป็นคณะทำงาน เป็นระเบียบ เป็นประกาศ เป็นหลักเกณฑ์ เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องตามประกาศนี้

ให้กรรมการกองทุน อนุกรรมการ และคณะทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในตำแหน่งต่อไปได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๑๖ ต่อไป

ข้อ ๒๘ การดำเนินงานใดที่สำนักงานยังไม่ได้กำหนดขึ้นตามประกาศนี้ ให้ใช้กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือส่วนราชการอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๒๙ ให้เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพัฒนา พร้อมพัฒน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

หมวด ๑

การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชี และรายงานของกองทุน

---

๑. การรับเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน

๑.๑ บรรดาเงินรายรับของกองทุนให้นำส่งเข้าบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัด... ที่เปิดบัญชีกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัด.....” ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบ

เว้นแต่กรณีที่ได้รับเงินค่าบริการสาธารณสุขอื่น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเปิดบัญชีกับธนาคารที่สำนักงานกำหนด โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัด... เพื่อบริการ...” แยกออกจากบัญชีกองทุนตามวรรคหนึ่ง

กรณีเงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจากแหล่งทุนอื่น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเปิดบัญชีแยกออกจากบัญชีกองทุนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ทั้งนี้ การเปิดบัญชีและชื่อบัญชีให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานเจ้าของแหล่งทุน

ทั้งนี้ บัญชีกองทุนที่ได้เปิดบัญชีไว้แล้วก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นบัญชีเงินฝากตามประกาศนี้

๑.๒ การรับเงินเข้ากองทุนให้รับเป็นเงินสด เช็ค หรือโอนเข้าบัญชีทางธนาคาร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) หรือวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด และให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินที่ได้รับการจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือการรับเงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ใช้หลักฐานการโอนเงินทางธนาคาร หรือหลักฐานอื่นที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร เป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชีรายรับ

๑.๓ เงินสดที่กองทุนได้รับไว้ ให้นำฝากเข้าบัญชีตามข้อ ๑.๑ ภายในวันที่ได้รับเงิน หากไม่สามารถนำเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย นำเงินสดจำนวนดังกล่าวเก็บรวมไว้ในซองหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุน จำนวนเงิน ปิดผนึกลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และนำฝากไว้ที่ตู้นิรภัยหรือสถานที่เก็บรักษาเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วให้นำฝากเข้าบัญชีในวันทำการถัดไป

๒. การจ่ายเงินกองทุน

๒.๑ การจ่ายเงินกองทุนให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งจ่ายตามเงื่อนไขข้อ ๑๑ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินกองทุนตามข้อ ๑๒ ให้เป็นตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงาน และหน่วยงานเจ้าของแหล่งทุนนั้น

๒.๒ วิธีการจ่ายเงินกองทุนให้จ่ายได้ ดังต่อไปนี้

๒.๒.๑ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม

๒.๒.๒ จ่ายเป็นการโอนเข้าบัญชีทางธนาคารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒.๓ จ่ายวิธีอื่นตามที่ตกลงกับสำนักงาน

๒.๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คนใดคนหนึ่ง ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายไว้จำนวนสองคน รวมเป็นผู้ลงนามหรืออนุมัติจำนวนสองคน เป็นผู้เบิกเงินจากบัญชีกองทุนตามเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุน

๒.๔ การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ให้ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าของหน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ให้กระทำได้ ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ชัดเจน

๒.๕ การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ไม่น้อยกว่าสองคนขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน

๒.๖ การจ่ายเงินกองทุนต้องมีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ

๓. การจัดทำบัญชีและรายงานกองทุน

๓.๑ การบันทึกบัญชี ให้บันทึกตามรูปแบบที่สำนักงานกำหนด

๓.๒ รอบระยะเวลาบัญชีให้ถือตามปีงบประมาณ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เข้าร่วมดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีให้เริ่มระบบบัญชี ณ วันที่ได้รับเงินเป็นครั้งแรกจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๓.๓ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ หรือระบบอื่น และจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ทุกไตรมาส โดยให้จัดส่งภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาส ตามรูปแบบที่สำนักงานกำหนด

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุน ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ

๓.๔ การจัดทำบัญชีและรายงานการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนอื่น ให้เป็นตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงาน และหน่วยงานเจ้าของแหล่งทุนนั้น

หมวด ๒
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือแผนการดูแลรายบุคคล

---

๔. กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น

๔.๑ เมื่อได้รับเงินจากกองทุนให้นำไปใช้จ่ายตามที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน และการจัดทำบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบที่หน่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ

๔.๒ เก็บหลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้เพื่อการตรวจสอบ

๔.๓ เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้รายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการจ่ายเงิน ตามที่สำนักงานกำหนด เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนทราบและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ

๔.๔ กรณีที่มีเงินเหลือจากการดำเนินงานให้นำเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงานตามที่ได้รับอนุมัติ

๕. กรณีองค์กรหรือกลุ่มประชาชน

๕.๑ เมื่อได้รับเงินจากกองทุนให้นำไปใช้จ่ายตามที่ได้รับอนุมัติ

๕.๒ การจัดซื้อจัดจ้างให้ถือราคากลางตามระเบียบของทางราชการ หรือราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง และให้แนบเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงินไว้กับรายงานการจ่ายเงินดังกล่าวด้วย

๕.๓ เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้รายงานผลการดำเนินงานและรายงานการจ่ายเงิน ตามที่สำนักงานกำหนด เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนทราบ และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ

๕.๔ กรณีที่มีเงินเหลือจากการดำเนินงานให้นำเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงานตามที่ได้รับอนุมัติ

๖. กรณีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนอื่น ให้เป็นตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงาน และหน่วยงานเจ้าของแหล่งทุนนั้น

หมวด ๓

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
ในการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน

---

๗. ค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้าประชุมตามข้อ ๒๓ ให้จ่ายในอัตรา ดังต่อไปนี้

๗.๑ ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการกองทุน ไม่เกินครั้งละ ๕๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

๗.๒ ค่าตอบแทนในการประชุมคณะอนุกรรมการ ไม่เกินครั้งละ ๔๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๘๐๐ บาท

๗.๓ ค่าตอบแทนในการประชุมคณะทำงาน ไม่เกินครั้งละ ๓๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๖๐๐ บาท

๘. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้าประชุมตามข้อ ๒๓ ให้จ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๙. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการประชุม ให้จ่ายในอัตราเทียบเคียงตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง